

RUBENS PEREIRA DOS SANTOS

HD:

AOS

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

10/09 P= 11.6 cmH₂O

21 IAH= 6.9

m. de uso: 4h 30

fua

18/10

P= 11.6

IAH= 2.0

m. de uso: 4:20

Bem adaptado

fua

P= 10.2

IAH= 6.3

m. de uso: 3h 24

fua

05/07/23 P= 7.6 cmH₂O

IAH= 3.9 e/h

m. de uso= 4h 10 min (Auto: 5" a 10 cmH₂O.)

→ sondência

pouco prunes?

* aparelho q defeito - peça posterior quebrada

↳ enviado p/ manutenção

↳ fez troca de bateria

23 P= 8.9 cmH₂O

10 IAH= 4.0 e/h

24 m. de uso: 4h 35'

Bem adaptado, relata

que dorme 1 h, antes do

sono principal.

troca o filtro

fua



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPES
Especialização em Medicina do Sono
Secretaria Executiva de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Exatador em Clínica para Jovens
CRM-SP: 69.730

Medicina do Sono
Clínica de Sono
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Rubens Pereira dos Santos
EXAME nº: 4921
SOLICITADO POR: Dra. Ercio Alvaro Nakano
DATA: 20/07/2021
IDADE: 55 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h29min e concluído às 06h18min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 64 minutos. O tempo total de sono foi de 416 (06h56min) minutos, com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 89,3%. A distribuição do sono mostrou 14,7% de estágio 1, 50,5% de estágio 2, 16,2% de estágio 3 e 18,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 48,5 minutos em vigília, ocorreram 266 microdespertares (índice: 38,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 59,1/hora, sendo 35,2 apneia/hora e 23,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 59,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, a média de 87% e a mínima de 71%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (59,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (59,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o decúbito dorsal, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 61; máxima: 83 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (64 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (89,3%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 38,4/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (14,7%; normal: 8-10%) e 3 (16,2%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (18,6%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (50,5%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 15 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Nome: RUBENS PEREIRA DOS SANTOS
Data de Nascimento: 28-5-1966
IMC: 26,49
Sexo: Masculino
Data do exame: 17-08-2021

Peso: 83 kg
Altura: 1,77 m
Medico: DR. ERCIO ALVARO NAKANO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 17-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 437,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 2,5 e 92,5 minutos. O tempo total de sono foi de 338,0, eficiência de 77,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 54,0%; estágio N3: 23,5%; sono REM: 20,7%. O índice de despertares foi de 13,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 19,0/hora, sendo elas 18 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 89 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 80%, permanecendo 4,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 94 bpm e NREM de 62 - 95 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

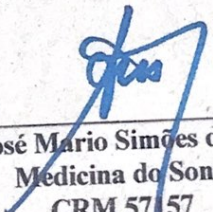
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono normais;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 11 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

IAH = 59%


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57